Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 7–10 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

THEORETISCHER BEITRAG

Lebenssinn als transdiagnostischer Faktor

Begriffliche Klärungen, theoretische Modelle und offene Fragen

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Transdiagnostische Ansätze untersuchen psychologische Merkmale und Prozesse, die über verschiedene Störungsbilder hinweg an Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Beschwerden beteiligt sind. Der vorliegende theoretische Beitrag prüft, ob und in welchem Sinne Lebenssinn als transdiagnostischer Faktor konzipiert werden kann. Ausgehend von den Kriterien, die in der transdiagnostischen Literatur für entsprechende Konstrukte diskutiert werden, wird zunächst der Begriff des Lebenssinns präzisiert. Unterschieden werden das Vorhandensein von Sinn, die Suche nach Sinn sowie die Komponenten Kohärenz, Zielorientierung und Bedeutsamkeit. Anschließend werden drei Modellvorstellungen gegenübergestellt: Lebenssinn als Vulnerabilitäts- bzw. Schutzfaktor, als Ergebnis gelingender Bedeutungsbildung nach belastenden Ereignissen und als Ausdruck übergreifender Motivationsstrukturen. Es wird argumentiert, dass ein Mangel an erlebtem Sinn weniger als eigenständiger Mechanismus denn als Knotenpunkt verstanden werden sollte, an dem motivationale, kognitive und emotionale Prozesse zusammenlaufen. Abschließend werden Implikationen für Diagnostik und Psychotherapie diskutiert sowie methodische Anforderungen formuliert, die für eine empirische Prüfung des transdiagnostischen Status von Lebenssinn erforderlich wären, insbesondere längsschnittliche Designs, die Trennung konzeptuell überlappender Konstrukte und die Berücksichtigung kultureller Variabilität.

Schlüsselwörter: Lebenssinn · Transdiagnostik · Psychopathologie · Bedeutungsbildung · Schutzfaktoren

ABSTRACT

Transdiagnostic approaches investigate psychological characteristics and processes that contribute to the onset and maintenance of psychological problems across diagnostic categories. This theoretical paper examines whether, and in what sense, meaning in life can be conceptualized as a transdiagnostic factor. Drawing on criteria discussed in the transdiagnostic literature, the paper first clarifies the concept of meaning in life, distinguishing between presence of meaning and search for meaning as well as between the components of coherence, purpose, and significance. Three models are then contrasted: meaning in life as a vulnerability or protective factor, as an outcome of successful meaning making after stressful events, and as an expression of overarching motivational structures. It is argued that a lack of experienced meaning should be understood less as a distinct mechanism than as a nodal point at which motivational, cognitive, and emotional processes converge. Finally, implications for assessment and psychotherapy are discussed, and methodological requirements for an empirical test of the transdiagnostic status of meaning in life are outlined, in particular longitudinal designs, the separation of conceptually overlapping constructs, and attention to cultural variability.

Keywords: meaning in life · transdiagnostic approach · psychopathology · meaning making · protective factors

1 Einleitung

Die kategoriale Klassifikation psychischer Störungen hat sich für Verständigung, Versorgung und Forschung als unverzichtbar erwiesen. Zugleich sind ihre Grenzen seit Langem bekannt: Hohe Komorbiditätsraten, unscharfe Übergänge zwischen Diagnosen und die Beobachtung, dass ähnliche psychologische Prozesse bei unterschiedlichen Störungen wirksam sind, haben zu einer transdiagnostischen Perspektive geführt. Harvey et al. (2004) haben in einer einflussreichen Monografie gezeigt, dass Prozesse wie selektive Aufmerksamkeit, repetitives negatives Denken oder Vermeidungsverhalten über zahlreiche Störungsbilder hinweg auftreten. Auf struktureller Ebene wurde zudem diskutiert, ob sich ein allgemeiner

Psychopathologiefaktor identifizieren lässt (Caspi et al., 2014).

Vor diesem Hintergrund liegt die Frage nahe, ob auch Lebenssinn – oder sein Fehlen – als transdiagnostischer Faktor verstanden werden kann. Die Logotherapie hat eine solche Annahme in gewisser Weise vorweggenommen, indem sie die Frustration des Willens zum Sinn als Bedingung beschrieb, die sich in unterschiedlichen Symptomen äußern kann (Frankl, 1969). Der vorliegende Beitrag prüft diese Intuition im Licht gegenwärtiger theoretischer Kriterien. Er versteht sich als konzeptuelle Analyse und nicht als Zusammenfassung eigener empirischer Daten.

2 Kriterien für transdiagnostische Konstrukte

Nolen-Hoeksema und Watkins (2011) haben eine Heuristik vorgeschlagen, mit der sich transdiagnostische Modelle präzisieren lassen. Sie unterscheiden distale Risikofaktoren, die die Vulnerabilität erhöhen, proximale Prozesse, die unmittelbar an der Symptombildung beteiligt sind, und moderierende Bedingungen, die erklären, warum ein gemeinsamer Faktor bei verschiedenen Personen zu unterschiedlichen Störungen führt. Ein Konstrukt verdient demnach nicht schon deshalb die Bezeichnung „transdiagnostisch", weil es mit mehreren Störungen korreliert. Erforderlich ist vielmehr ein theoretisch begründetes Modell darüber, wie es auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Symptomen einwirkt.

Für den Lebenssinn ergibt sich daraus eine doppelte Aufgabe. Erstens muss geklärt werden, was genau unter Lebenssinn verstanden wird. Zweitens ist zu bestimmen, auf welcher Ebene des Modells – als distaler Faktor, als proximaler Prozess oder als Moderator – er angesiedelt sein soll. Beide Fragen werden in der Literatur nicht immer hinreichend auseinandergehalten.

3 Begriffliche Präzisierung

Steger et al. (2006) haben mit der Unterscheidung zwischen dem Vorhandensein von Sinn und der Suche nach Sinn eine für die empirische Forschung folgenreiche Differenzierung eingeführt. Während das erlebte Vorhandensein von Sinn in der Regel mit Wohlbefinden einhergeht, ist der Zusammenhang der Sinnsuche mit psychischer Gesundheit komplexer und offenbar vom Kontext abhängig. Martela und Steger (2016) haben darüber hinaus drei Facetten des Sinnerlebens unterschieden: Kohärenz im Sinne der Verstehbarkeit des eigenen Lebens, Zielorientierung im Sinne einer motivierenden Ausrichtung auf wertgeschätzte Ziele und Bedeutsamkeit im Sinne des Erlebens, dass das eigene Leben wertvoll ist und zählt.

Schnell (2009) hat zudem gezeigt, dass zwischen den Quellen, aus denen Menschen Sinn beziehen, und dem globalen Sinnerleben unterschieden werden sollte. Diese Unterscheidung ist klinisch bedeutsam: Ein Mangel an erlebtem Sinn kann auf den Verlust einzelner Sinnquellen, auf eine geringe Vielfalt solcher Quellen oder auf eine fehlende Integration in ein übergreifendes Selbstverständnis zurückgehen. Ferner hat Schnell (2020) auf den Zustand der „existenziellen Indifferenz" hingewiesen, bei dem weder Sinn erlebt noch gesucht wird – ein Zustand, der sich von einer akuten Sinnkrise deutlich unterscheidet.

Für die transdiagnostische Frage folgt daraus, dass „Lebenssinn" kein einheitliches Konstrukt ist. Wer von Sinn als transdiagnostischem Faktor spricht, muss angeben, welche Facette gemeint ist, da Kohärenz, Zielorientierung und Bedeutsamkeit potenziell mit unterschiedlichen psychopathologischen Prozessen verknüpft sind.

Hinzu kommt, dass Sinnerleben und Sinnsuche nicht als Gegenpole einer einzigen Dimension verstanden werden sollten (Steger et al., 2006). Eine Person kann ihr Leben als sinnvoll erleben und zugleich nach vertieftem Sinn suchen; umgekehrt kann jemand wenig Sinn erleben, ohne aktiv danach zu suchen. Diese Konstellationen haben vermutlich unterschiedliche klinische Bedeutung, was bei der Formulierung transdiagnostischer Hypothesen berücksichtigt werden muss.

4 Drei Modellvorstellungen

Ein erstes Modell versteht erlebten Sinn als Schutzfaktor und seinen Mangel als Vulnerabilitätsfaktor. Diese Sichtweise ist mit salutogenetischen Überlegungen verwandt, wie sie Antonovsky (1987) mit dem Konzept des Kohärenzgefühls formuliert hat, in dem die Sinnhaftigkeit als motivationale Komponente eine zentrale Stellung einnimmt. In diesem Modell wäre Lebenssinn ein distaler Faktor im Sinne von Nolen-Hoeksema und Watkins (2011), der die Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Störungen beeinflusst, ohne deren spezifische Gestalt festzulegen.

Ein zweites Modell betont die Prozessdimension. Park (2010) beschreibt in ihrem Meaning-Making-Modell, wie belastende Ereignisse eine Diskrepanz zwischen globalen Bedeutungsstrukturen und der situativen Bewertung eines Ereignisses erzeugen, die

durch Prozesse der Bedeutungsbildung verringert werden kann. Psychische Beschwerden ließen sich in diesem Rahmen als Ausdruck nicht gelingender Bedeutungsbildung verstehen. Hier ist Sinn nicht primär ein stabiles Merkmal, sondern ein Ergebnis fortlaufender Verarbeitung, das proximal an der Aufrechterhaltung von Symptomen beteiligt sein kann.

Ein drittes Modell schließlich deutet Sinnerleben als Ausdruck übergreifender Motivationsstrukturen. Baumeister (1991) hat Sinnbedürfnisse in Bezug auf Zweck, Werte, Wirksamkeit und Selbstwert beschrieben. Aus dieser Perspektive verweist ein Mangel an Sinn auf eine Störung motivationaler Ausrichtung, die sich etwa in Antriebsminderung, Vermeidungsverhalten oder kompensatorischen Strategien äußern kann. Auch Yalom (1980) hat Sinnlosigkeit als eine der existenziellen Grundgegebenheiten beschrieben, mit der Menschen in sehr unterschiedlicher, teils dysfunktionaler Weise umgehen.

Die Logotherapie lässt sich keinem dieser Modelle eindeutig zuordnen. Frankls Konzept der noogenen Neurose beschreibt Beschwerden, die primär aus einem existenziellen Konflikt oder einer Sinnfrustration hervorgehen (Frankl, 1969). Damit nimmt es eine spezifische Ätiologie an, die sich von psychogenen und somatogenen Störungen unterscheiden soll. Zugleich betont Frankl, dass ein existenzielles Vakuum auch ohne Krankheitswert bestehen und sich in unterschiedlichen Ausdrucksformen zeigen kann. Aus transdiagnostischer Sicht ist diese Doppelfunktion bemerkenswert, weil sie Sinnfrustration sowohl als spezifische Ursache als auch als unspezifischen Hintergrundfaktor konzipiert.

5 Sinn als Knotenpunkt: Eine integrative Deutung

Die drei Modelle schließen einander nicht aus. Es spricht vieles dafür, einen Mangel an erlebtem Sinn weniger als eigenständigen, isolierbaren Mechanismus denn als Knotenpunkt zu verstehen, an dem motivationale, kognitive und emotionale Prozesse zusammenlaufen. Befunde, nach denen positiver Affekt das momentane Sinnerleben beeinflusst (King et al., 2006), verdeutlichen, dass Sinnerleben nicht unabhängig von der affektiven Lage einer Person ist. Umgekehrt ist plausibel, dass eine stabile Wertorientierung affektive Krisen abpuffern kann.

Eine solche Knotenpunkt-Deutung hat Konsequenzen für die Forschung. Sie warnt davor, Sinnerleben als bloße Spiegelung depressiver Symptomatik zu behandeln, ebenso wie davor, es zu einem allumfassenden Erklärungsprinzip zu überhöhen. Heintzelman und King (2014) haben zudem darauf hingewiesen, dass die meisten Menschen ihr Leben als recht sinnvoll beschreiben. Ein klinisch relevanter Sinnmangel ist demnach eher die Ausnahme als die Regel, was für die Bestimmung von Schwellenwerten und Risikogruppen bedeutsam ist.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Richtung der Zusammenhänge. Querschnittliche Korrelationen zwischen geringem Sinnerleben und psychischen Beschwerden sind mit mehreren Kausalannahmen vereinbar: Ein Mangel an Sinn kann Beschwerden begünstigen, Beschwerden können das Sinnerleben beeinträchtigen, oder beide können auf gemeinsame dritte Faktoren zurückgehen. Ein transdiagnostisches Modell muss diese Möglichkeiten explizit unterscheiden und darf aus Zusammenhängen nicht vorschnell auf Wirkrichtungen schließen.

6 Implikationen und offene Fragen

Für die Diagnostik legt die Analyse nahe, Sinnerleben facettenspezifisch und störungsübergreifend zu erfassen, statt es lediglich als Begleitvariable zu erheben. Für die Psychotherapie ergibt sich die Überlegung, ob sinnzentrierte Interventionen als ergänzende Module in unterschiedlichen Behandlungskontexten eingesetzt werden können. Dies entspräche Frankls Selbstverständnis der Logotherapie als Ergänzung anderer Verfahren.

Für eine empirische Prüfung des transdiagnostischen Status von Lebenssinn wären insbesondere längsschnittliche Designs erforderlich, die zeitliche Abfolgen zwischen Sinnerleben und Symptomentwicklung abbilden, ferner eine sorgfältige Trennung konzeptuell überlappender Konstrukte wie Hoffnungslosigkeit, Wohlbefinden oder Selbstwirksamkeit sowie die Berücksichtigung kultureller Variabilität in der Bedeutung von Sinn. Solange diese Anforderungen nicht erfüllt sind, ist die Rede von Lebenssinn als transdiagnostischem Faktor als heuristisch fruchtbare Hypothese, nicht als gesicherter Befund zu verstehen.

Für die therapeutische Praxis ist zudem zu bedenken, dass die Thematisierung von Sinn nicht zu jedem Zeitpunkt einer Behandlung angemessen ist. In akuten Krisen, bei schwerer depressiver Symptomatik oder bei ausgeprägter Antriebsminderung kann die explizite Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens überfordern oder Gefühle des Versagens verstärken. Ein transdiagnostisches Verständnis von Sinn spricht

daher nicht für eine undifferenzierte Anwendung sinnzentrierter Techniken, sondern für eine sorgfältige Indikationsstellung, die den Zustand der Person, ihre Ressourcen und den Behandlungsverlauf berücksichtigt.

Literatur

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass.

Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. Guilford Press.

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., Meier, M. H., Ramrakha, S., Shalev, I., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science, 2(2), 119–137.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Harvey, A. G., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford University Press.

Heintzelman, S. J., & King, L. A. (2014). Life is pretty meaningful. American Psychologist, 69(6), 561–574.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1), 179–196.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Nolen-Hoeksema, S., & Watkins, E. R. (2011). A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology: Explaining multifinality and divergent trajectories. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 589–609.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483–499.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Meaning in Life as a Transdiagnostic Factor: Conceptual Clarifications, Theoretical Models, and Open Questions. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 7–10.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.